

ORL

Dr.KHERBA_N

ORL

Abcès dentaire

Acouphènes

Angines

Aphtes

Bouchon de cérumen

Candidose buccale

Épistaxis

Éthmoïdite

Laryngite

Maladie de Behçet

Otite externe aigue

Otite moyenne aigue

Otomycose

Périchondrite

Pharyngite

Rhinite allergique

Rhinopharyngite

Scarlatine

Sinusite

Syndrome grippal

Abcès dentaire

1 Augmentin St 1g 1sac 3/j pdt 10j

Ou Amoxicilline 1g 1cp 3/j

+ Flagyl cp 500 mg 1cp 3/j pdt 7j

2 Doliprane cp 1g 1cp 2/j

3 Bain de bouche Eludril BDB 1/j pdt 5j

Ou

1 Biorogyl cp 2cp 2/j pdt 10j

2 Dolyc 1000mg

Soit Augmentin seul ou Amoxicilline + Flagyl

⊖ AINS sont CI : Risque de cellulite

→ Orientation vers un dentiste

Acouphènes

● Clinique:

- Bruits (sifflements, bourdonnements, grésillements.. que l'on entend dans une oreille..)
- Vasculaire: si oreille saine=> IRM
- Si triade: Acouphènes + hypoacousie + vertiges=> Maladie de Ménière
- Pulsatile=> IRM (Maladie d'Horton)
- Os de l'oreille=> TDM
- Bilatéral=> HTA

✓ Traitement: symptomatique

Neurovit

Angines

● Clinique:

- Gonflement des amygdales, gorge rouge, fièvre
- Erythémato pultacée=> pas toujours d'origine bactérienne
- Fausse membranes=> MNI ou Diphtérie
- Ulcéro nécrotique=> toujours unilatérale:
Angine de Vincent

- Angine érythémato pultacée

→ Virale/Strepto

- Angine pseudo membraneuse:

→ Diphtérie/MNI

Prélèvement de gorge

■ Angine ulcéro nécrotique

→ Hémopathie (Leucémie): FNS/Frottis

→ Angine de Vincent: prélèvement de gorge

→ Syphilis: Sérologie

■ Angine vésiculeuse

→ Virale

✓ Traitement :

1 Clamoxyl 1g 1cp 2/j pdt 6j à 12h d'intervalle

2 Paracétamol cp 1cp 3/j

3 Vit C cp 1cp/j le matin

4 Hexaspray 3/j ne dépasse pas 5j

Ou Thymospetine à gargariser puis à avaler (CI chez les épileptiques)

■ Si fièvre ↗: Amoxicilline inj 1g

Ou Peni G 1MUI 1inj/j pdt 7j

Peni V 1MUI 1cp 3/j

■ Enfant

■ <2ans: viral que traitement symptomatique

=> Antipyrétique + désobstruction nasale

Si non Amoxicilline 50mg/kg/j pdt 10j

■ >2ans: strepto

1 Clamoxyl sirop 50mg/kg/j 1cam 2/j pdt 7j à 12h d'intervalle

Ou >30mois: 60mg/kg/j

2 Paracétamol 60mg/kg

■ Si Vomissements :

Domperidone >12ans sirop 1ddp 2/j 15min avant repas

■ Si Diarrhées :

Smecta st 1st 2/j

+ SRO St 1st dans 1l d'eau

- Si Douleur abdominale :

Débridat sirop 1cam 2/j

- Si Angine + Fièvre et malgré le traitement la T° toujours => Amoxicilline non efficace

Ou si allergie aux Pénicillines: Clarithromycine

1 Efferalgan sirop 1cam/8h

2 Zeclar sirop 1ddp 2/j pdt 5j

<25kg: 25

>25kg: 50

Ou Rovadal sirop 1cam 2/j pdt 10j

- Après 4ans si: Angine à répétition => bilan ASLO(+) Si: > 400

- Extencilline pour lutter contre RAA: 3inj

0.6 M<30kg 1.2M>30kg

1inj/21j en IM stricte dans un milieu hospitalier



Angine de Vincent

● Clinique: Ulcéro nécrotique noirâtre

- Douleur vive localisée sur une seule moitié de la gorge et s'aggrave en avalant
- Ulcérations recouvertes d'un pseudomembrane grisâtre apparaissent sur les gencives et les amygdales
- Haleine fétide très désagréable en raison de la présence des bactéries
- Fièvre modérée, adénopathies cervicales

→ Confirmation par frottis et culture anaérobie

- Antibiothérapie : Pénicilline ou Amoxicilline + Métronidazole
- Soins bucco_dentaires
- Bain de bouche antiseptique (Chlorhexidine)
- Arrêt du tabac si fumeur

- Rechercher une immunodépression

Sérologie: HIV, HBS, HCV, TPHA, VDRL

- Bilan: 

- FNS (Hémopathie)

- Glycémie à jeûne

- CRP/VS



Aphtes

● Clinique : Ulcère superficiel douloureux de la muqueuse buccale ou d'un autre organe.. à l'intérieur +++

Vérifier si y a pas des aphtes anales=> Maladie de Behçet.

■ Rechercher une immunodépression :

Maladie coéliquaue

Dosage de B12

Carence en vit D

Sérologie

Diabète

Behçet

Stress..

✓ Traitement :Adulte

- Suppression des aliments favorisants : épices, amères, acides, trop chaud, trop froid, fraise..

Aptus cp 1cp 3/j 1bte à partir de 5ans

Ou Urgo aphtes 1pul 3/j

Ou Hysadril sol 1app 2/j bain de bouche

Ou Alocclair aphte

Ou Leadermax aphte

Ou Atocclair gel ou spray

Ou Bain de bouche au bleu de méthylène 1app/j
le soir/ bicarbonate de soude 1app 3/j eau salée

+/_ Xlylocaïn pmd (anesthésie locale) 2app/j
après repas.

■ Enfant 🧒 :

<6mois : Abstention thérapeutique

Bicarbonate 1c dans un verre d'eau

>6mois :

Stop aphtes junior

⊖ Daktazol est CI

On ne donner pas en 1ere intention un traitement antifongique réservé aux candidoses buccales.



Bouchon du cérumen

● Clinique :

Empêchent d'entendre, sensation d'oreille bouchée qui s'accroît après la douche, bourdonnements+

✓ Traitement :

Cerulyse gtt 5gtt 3/j pdt 5j

Ou Orilyse gtt 0.5g/100ml 3/j pdt 5j

⊖ CI si Tympan perforé

■ Enfant 🧒

1 A Cérumen gtt 3gtt 3/j pdt 5j

2 H₂O₂ sol eau oxygénée 3gtt 3/j 15min après
Cérulyse

- Extraction du bouchon après 5j chez un ORL
- Enfant <7ans et le diabétique => lavage CI (inspiration)
- Lavage CI en cas de perforation tympanique



Candidose buccale = Muguet

● Clinique :

Infection fongique formant des tâches blanchâtres douloureuses..

✓ Traitement :

■ Fungizone susp buv 1ml/2kg/j 5cc bain de bouche pdt 1min 4/j pdt 2sem

Ou Fungizone sirop ½ cà m à badigeonner et 1 cà m à avaler

Ou Fungivit 1 cà m 2/j / Daktagel 1 app 2/j

■ Si échec :

■ Fluconazole gel 100mg pdt 2sem

2gel le 1^{er} j puis 1gel le reste des j

Ou Diflucan gel 50mg 3gel/j en monoprise

Ou Mytricine

■ Rechercher une immunodépression :

■ Bilan 

■ FNS

■ Glycémie

■ Sérologie

■ CDU

■ Enfant : 

■ Stériliser les biberons chaque jour

■ Éviter les sucres

■ Fungizone susp buv 1càc pour 10kg/j 2_3/j pdt 14_21j

1 flc=> NRS et enfants 50mg/kg/j

1cac dans un verre d'eau : Nettoyage par une compresse

Ou Daktren (Miconazole) 2% gel buv 1app 3/j
NRS >6mois

<6mois: Nystatine sirop 1cam 2/j

+ Frotter avec compresse imbibée au Bicarbonate et de l'eau

+/_ Neobiotic gtt 7gtt 2fois pdt 4sem

■ NRS : 4_24mois=> 1.25ml 4/j après repas

>2ans=> 2.5ml

Adulte=> 5ml

⊖ Daktren est CI avant 2ans

⇒ Mytricine 1app avant chaque repas



Épistaxis

● Clinique :

Hémorragie extériorisée par les fosses nasales.

Signes de gravité : Hypotension, pâleur, tachycardie

Éliminer : Hémoptysie, Hématémèse

Si c'est un homme fumeur=> Kc du cavum=> TDM / Nasofibroscopie (ORL)

■ Causes : Infections (Rhinite/Sinusite), tumeurs, HTA, traumatisme, troubles d'hémostase, iatrogène (AVK, Aspirine..)

■ Bilan d'hémostase avant tout :

■ FNS/TP/TCK

■ TA

Si répétition en grande abondance=> FNS

Si chronique → Avis ORL

- Position demi assise légèrement penché en avant

- Mouchage : par SSI pour débarrasser les caillots du sang

- Méchage nasale : tête surélevée pencher en avant puis compression bidigitalique pdt 10min

Antérieur si non réponse=> postérieur

- Dicynone ½ amp en IV ou IM ou dans ½ verre d'eau si Enfant / Adulte 1amp

✓ Traitement :

■ Petite abondance :

1 HEC pmd 1app 2/j

2 Mebo pmd 1app 2/j

3 Habermi pmd 1app 2/j

■ Grande abondance :

1 Dicynone cp 250mg 2cp 2/j Ou 1cp 3/j pour adulte

2 Dicynone inj 1inj le matin 1bte

Ethmoïdite

Clinique :

- Infection bactérienne des cellules aériques de l'ethmoïde.

Âgé 2_8ans, AEG, fièvre, exophtalmie, chémosis
céphalées fronto_orbitaire, rhinorrhée
purulente unilatérale, œdème palpébral
unilatéral douloureux

- Contexte d'une Rhinopharyngite
- Triade de collection : Immobilité de GO,
anesthésie cornéenne, mydriase paralytique.

Hospitalisation :

- Bilan : FNS/CRP
- Hémoculture
- TDM en urgence
- Drainage chirurgicale

■ Traitement :

ATB en IV (C3G + Métronidazole) + CTC

→ Avis ophtalmologie + TDM

Laryngite

● Clinique :

Dyspnée inspiratoire, râles sibilants, toux, fièvre, voix rauque, tirage, cornage, battements des ailes du nez, cyanose, stridor inspiratoire, tachypnée..

⊖ Abaisse langue et le décubitus dorsal sont CI risque d'épiglottite

■ Enfant 🧒

● Laryngite sous glottique : 1_3an

■ Forme grave : Détresse respiratoire++

➡ Hospitalisation

■ Dexaméthasone 0.5mg/kg en IV ou IM max 12mg

Ou Prednisone (Solumedrol) 1_2mg/kg en IV ou IM

Si persistance renouveler inj

■Nébulisation Adrénaline 1cc Dexta 2cc dans 3cc SSI 20min (jusqu'à 3 séance)

Aérosol d'Adrénaline : 5mg/10ml NaCl 9%
15min

■Si réponse => Traitement de sortie

✓ Traitement de sortie :

1 CTC per os pdt 5j le matin :

<10Kg=> Celestene 10gtt/kg max 400gtt

>10Kg=> Solupred cp 5mg 1mg/kg/j max : 40mg

Predo sirop : poids/3= ?ml 1/j

ATB si : Laryngite sévère ou fébrile

2 Augmentin sirop 1ddp 2/j pdt 7j 80mg/kg/j

3 Paracétamol

4 AH : Tifen ou Deslor sirop. Si NRS : Primalan

5 SSI

- Stade 1 : Traitement ambulatoire par une CTC
- Stade 2 : Dexa 0.6mg/kg en IM
- Stade 3 : Adrénaline 0.1cc/kg sans dépasser 5cc dans 3cc de SSI + Dexa en IV + ATB en IV

● Laryngite sus glottique : Grave

Fébrile, teint grisâtre, bouche ouverte, dyspnée brutale sévère => risque de collapsus

→ Réa pédiatrique

■ Adulte :

✓ Traitement :

■ O2 thérapie

■ HHC inj 200mg en IV

1 Amoxicilline 1g 2/j si non Zomax si fièvre

2 Solupred 20_50mg 2_3cp/j le matin pdt 5j

3 AH : Bilaxten cp 1cp/j le soir

4 Nasabec 03pul/j

5 AT (Toplexil/si diabétique : Bronchocalm)

Maladie de Behçet

● Clinique

Aphthose récidivante bipolaire buccale, génitale, articulaire, cutanée (Folliculite, érythème noueux)..

■ Forme bénigne :

Aphtes buccales +/- génitales douloureux mais sans atteinte systémique (oculaire, neurologique, vasculaire..), absence des signes infectieux ni AEG

⇒ Pas besoin d'hospitalisation

■ Forme modérée à sévère :

Aphtes très nombreux, fièvre, AEG, arthrite, signes neurologiques, digestifs, vasculaire..

⇒ Hospitalisation (médecine interne)

⚠ 3 épisodes aphtosiques pendant une année
fait suspecter la maladie de Behçet

■ Pour l'enfant cette maladie est rare, le diagnostic après l'âge de 15ans..

■ Bilan : 

■ FNS : Hyperleucocytose à PNN

■ CRP/VS : syndrome inflammatoire

✓ Traitement :

■ Pousée => Colchicine 1_2mg/j

■ Fond => CTC oral Prednisone 0.5mg/kg/j pdt 7_10j avec décroissance rapide

■ Traitement local des aphtes : bain de bouche, anesthésie locaux « Xylocaïn »

■ Crème corticoïde pour les aphtes génitales

■ Supplémentation vitaminique en B9 B12

■ Si échec => immunodépresseurs

✳ Diagnostic Positif :

Le diagnostic de la maladie de Behçet se fait de nos jours par la nouvelle classification (critères internationaux 2013). Le diagnostic est retenu si le score est égal ou supérieur à 4:

- ✓ Atteinte ophtalmologique:(2 points);
- ✓ Aphtose génitale:(2 points);
- ✓ Aphtose buccale:(2 points);
- ✓ Manifestations cutanées:(1 point);
- ✓ Manifestations neurologiques:(1 point);
- ✓ Manifestations vasculaires:(1 point);
- ✓ Test de pathergie:(1 point).



Otite externe aigue

● Clinique :

- Inflammation aiguë de l'oreille et plus précisément, de la peau du conduit auditif externe, bactérienne++
- Douleur lors de traction du pavillon ou appui sur le tragus
- Pour différencier OMA : Tympan touché + vertiges

✓ Traitement :

- Tympan perforé ou non visualisé :

1 Otofa gtt pdt 7j

Adulte : 5gtt 2/j

Enfant : 3gtt 2/j

■ Tympan non perforé :

1 Otocine dosette pdt 10j à partir 2ans

Adulte 1dosette 2/j

Enfant ½ dosette 2/j

Ou Polydexa sol 1_5gtt 2/j pdt 10j

2 Doliprane cp 1g 1cp 2/j

■ Si complications : Augmentin per os pdt 10j

■ Si Otite externe maligne ou ID :

Ciprolon cp 500mg 1cp 2/j pdt 10j

■ NRS : 🤖 rare

Polydexa gtt si Tympan fermé



Otite moyenne aigue OMA

● Clinique :

- Infection bactérienne ou virale suite à une Rhinopharyngite
- Oalgies, Otorrhées, fièvre, troubles digestifs (diarrhées, vomissements)
- Tympan touché, vertiges, Insomnie..
- Otoscopie : Tympan enflammé rouge, jaune ou blanche (pus), bombement..

- Tympan est rouge, sans épanchement = OMA congestive, d'origine virale = guérison spontanément, sans traitement antibiotique

- Tympan opaque, congestionné et bombé, avec épanchement purulent = OMA purulente, d'origine bactérienne = Traitement antibiotique nécessaire

■ Tympan perforé, avec Otorrhée purulente = otite perforée = contre indique le traitement local antiseptique

■ Tympan avec phlyctènes (citrin ou hématique) = myringite aiguë → Orientation ORL

⊖ ATB locaux sont CI dans les OMA

✓ Traitement :

■ Éviter l'entrée de l'eau pdt 3mois pour que la perforation se ferme..

■ Paracétamol 15mg/kg pour l'enfant

■ Augmentin 80mg/kg/j >30mois 50mg/kg/j <30

Enfant : sirop 1ddp 3/j pdt 10j

Adulte : st 1st 3/j

■ Si Résistance à l'Augmentin : Macrolide

Si chronique :

- Tympan perforé :

- Otofa gtt :

Adulte : 5gtt 3/j pdt 7j

Enfant : 3gtt 3/j pdt 7j

Ou Otocine dosette

- Tympan non perforé :

- Polydexa auriculaire

Ou Otipax gtt 1_2gtt 3/j pdt 5j

- Si Otorrhées=> Otocine dosette pdt 10j

Enfant : 1/2dosette 2/j Adulte : 1dosette 2/j

- Si Oalgies + Tympan intact=> Oricalm + Dolyc

- Otofa/Otocine/Otidis

- Aspiration si purulente

- Désobstruction nasale

- RDV de Contrôle 48h

Otomycose

● Clinique :

Atteinte unilatérale, acouphènes, sensation d'oreille bouchée et démangeaisons intenses.

✓ Traitement :

- Éviter le contact avec l'eau
- Si récurrence: Rechercher une ID (Diabète..)

1 Betadine sol ou H₂O₂ 15min avant toute app du traitement:

2 Pevaryl lait gtt 3_5gtt 3/j pdt 15j

Ou Auricularum gtt 3gtt 3/j pdt 15j

Ou Exoderil crème 1app 2/j pdt 14j

3 Doliprane cp 1g 1cp 2/j

4 Telfast cp 120mg 1cp le soir si prurit

■ Enfant 🧒

Pevaryl gtt 1 gtt 3/j

■ Aspiration après 4_5j



Périchondrite

● Clinique:

Inflammation du pavillon d'oreille suite à un traumatisme:

- Douleur du pavillon +++
- Rougeur respectant le lobule
- Gonflement diffus efface progressivement les reliefs

✓ Traitement:

- Pas de douche ni couverture, pas de CTC ni pression

1 Ciprolan cp 500mg 1cp 2/j pdt 10j
ou Omnicef gel 300mg 1gel 2/j pdt 7j

2 Antiseptique local

3 Dolyc cp 1g 1cp 3/j

Ou Augmentin 3/j + Fucidine pmd si suintement

▪ Contrôle après 48h si pas d'amélioration ou
abcédassions → Avis ORL



Pharyngite

● Clinique :

Maux de gorge, douleurs lors de la déglutition, des douleurs à la toux, sensation de sécheresse dans la gorge.

✓ Traitement :

- Collutoire : Hexa spray pulv 1pulv 3/j pdt 5j
- Courbatures : Vit C cp 500mg 1cp/j le matin
- Fièvre : Paracétamol cp 1g 1cp 3/j
- Rhinorrhées : Eau de mer 1pulv/narine 3/j
- Tisanes

■ Enfant 🧒 :

- Doliprane
- SSI



Rhinite allergique

● Clinique :

Picotements dans le nez, éternuements +++
écoulement bilatéral nasal clair, yeux gonflent,
rougissent et larmoient. Mais il n'y a pas de
fièvre

✓ Traitement :

1 CTC locaux : matin dans chaque narine

Beconase >3ans

Nasonax >3ans et adulte 2pul 2/j

Nasacort/Rhinocort/Flixonase >6ans 2pul 2/j

Nasacort pulv

3_12ans : 1pulv/j

>12ans : 2pulv/j

2 Antihistaminiques : soir

Adulte : Telfast cp 120mg 1cp/j

Zyrtec gtt : >2ans

2_6ans : 5gtt 2/j

6_12ans : 10gtt 2/j

>12ans : 20gtt/j ou cp 10mg/j

Ou Loratidine sirop : >2ans

>30kg : 2cam/j

<30kg : 1cam/j

Airditine ou Deslor sirop 1cam le soir

Ou Paloramine sirop 1cac 3/j

3 SSI 500cc 1lavage 3/j seringue 10cc

■ Femme enceinte

1 Loratidine cp 10mg 1cp le soir

2 Niframycine pulv 2_3pulv/j

3 Acaprid cp 10mg 1cp/j

4 Nasacort spray

Rhinopharyngite

● Clinique :

Infection virale, écoulement clair puis purulent et obstruction nasale, éternuements, perte de l'odorat et de goût, gorge rouge, +/- fièvre +/- toux.

✓ Traitement : symptomatique

1 Désobstruction nasale 4_6 installations/j SSI

2 Stérimer/Physiomer

3 Paracétamol 60mg/kg/j

■ Pas ATB : sauf si aggravation des symptômes ou fièvre ↗

■ Pas : CTC/AINS/Antitussifs

Scarlatine

● Clinique :

- Angine rouge en flamme érythémateuse ou érythémato pultacée, fièvre, Strepto +++
- Douleur abdominale, vomissements, ADP
- Exanthème généralisée maculopapuleux en nappe sans intervalle de peau saine respectant la région péri buccale
- Langue : V lingual puis framboisée dépaillée
- Test rapide TDR
- Déclaration obligatoire
- Eviction scolaire 15j

✓ Traitement :

- ATB : Amoxicilline Ou Augmentin
Ou Peni V Ou Zinnat

Si allergie aux bétalactamines : Zeclar

■Antipyrétique

■BU au j3



Sinusite aigue

● Clinique :

- Inflammation des sinus, cavités osseuses du visage et du crâne, fièvre, céphalées localisées en regard du sinus concerné, toux..
- Œdème periorbitaire (Éthmoïdite)
- Obstruction nasale, douleur à la palpation, exagérée en position penchée en avant, écoulement purulent uni ou bilatéral poster
- Notion : Rhinite allergique

- Rx de massif facial (opacité)=> Diagnostic
- Confirmer par TDM
- Si c'est chronique : TDM + Nasofibroscopie

 En urgence :

Perfalgan 1flc 15min

Ou Clofenal 1amp en IM

+ O2 5_10min

 Traitement de sortie :

■ CTC pdt 5j

■ Antihistaminique pdt 5j

■ Antalgique

■ ATB si fièvre ou persistance des symptômes
au-delà de 48h (Amoxicilline)

1 Augmentin St 1g 1st 3/j pdt 10j

2 Doliprane cp 1cp 3/j

3 Effipred 20mg le matin pdt 3_5j

4 Nasacort pulv 2pulv matin dans chaque
narine

5 Telfast cp 120mg 1cp/j le soir

Ou Zomax/Roxid/Lexin

■ Enfant 🧒 :

1 Amoxicilline 80mg/kg/j <3g/j 2_3/j pdt 10j

Ou Augmentin 3/j

<30mois : 50mg/kg/j

>30mois : 80mg/kg/j

2 CTC : matin

<10kg : Celestene gtt 10gtt/kg/j

>10kg : solupred cp 1mg/kg/j

3 Doliprane dose poids 3/j

4 Lavage nasale au SSI

Syndrome grippal

● Clinique :

Fièvre, maux de tête, toux sèche, fatigue, courbatures, frissons..

✓ Traitement :

1 Dolirhume cp 1cp 3/j Ou Humex

2 Efferalgan cp

3 Vit C cp 500mg 1cp 2/j matin et après midi

Ou Sargenor vit C amp 1amp 2/j

4 Soufrane sol 2pulv/narine 3/j

■ Femme enceinte

1 Amoxicilline cp 1g 1cp 3/j pdt 7j si fièvre

2 Paracétamol cp 500mg 1cp/6h

3 Vitamine C (Nutripower) et Zinc 1bte 1cp/j

- Vaccin des sujets à risque :

0.5ml en Sc en automne en dehors de toute infection ou congestion ORL

- Éviter l'exposition prolongée au soleil

- Repos, Tisanes..